

— 태국 · 보험 · 2027

초고령사회 진입 앞의 태국 보험시장

인구구조 전환이 생명·건강보험의 수요 곡선을 재편하고 있습니다. 건강 특약, 연금보험, 보장 격차가 2027년의 기회를 정의합니다.

국가
태국

섹터
보험

발행
2026년 5월

전망 기간
2027-2032

분석 방법론

본 보고서는 규제당국 공시, 업계 단체 통계, 인구 전망, 사업자 공개 자료를 삼각 검증하여 태국 보험시장에 대한 전망을 도출합니다. 모든 정량적 주장에는 인라인 출처 태그가 부기되며, **[Kira estimates]**는 당사 분석팀의 자체 합산 수치를 의미합니다.

주요 투입 자료

→ 규제·협회 데이터

보험위원회(OIC) 지침, 태국생명보험협회(TLAA) 및 손해보험협회 보험료 통계, 상장 보험사 공시 자료.

→ 인구·보건 시스템 분석

인구 고령화 전망, 보편적 의료보장 이용 실태 연구, 국가 보건 지출 계열 데이터로 수요 논거를 뒷받침합니다.

→ 분석팀 삼각 검증

공개 수치가 상충할 경우 당사 분석팀이 가장 방어 가능한 중간값으로 조정하고 KIRA 추정치로 태그합니다.

분석 범위 및 한계

→ 분석 단위

태국 국내 보험시장(생명·손해보험)을 인구 전환 관점에서 분석합니다. 재보험 및 역외 캡티브는 분석 범위 외입니다.

→ 통화 및 환산

태국 바트(THB)는 신고 기준으로 기재하며, USD 환산은 작업 환율 THB 34.5/USD를 적용한 방향성 수치입니다.

→ 전망 방식

전망 수치는 문서화된 기준 연도에 고정된 방향성 시나리오이며 점 예측이 아닙니다. 범위 제시는 실질적 불확실성을 반영합니다.

목차

04	경영진 요약 시장 현황, 인구구조 논거, 5가지 전략적 시사점	PG 04
06	인구구조 전환 고령사회에서 초고령사회로 — 수요 엔진	PG 07
07	건강보장 격차 공적 보장이 끝나는 곳에서 민간 보장이 시작된다	PG 08
08	시장 규모 및 상품 구성 종목별 보험료; 건강 특약·연금이 성장을 주도	PG 09
10	경쟁 구조 주요 생명보험사 및 시장 선도 사업자 프로파일	PG 11
13	규제와 비용 통제 기조 공동부담, RBC, IFRS 17	PG 14
15	유통·청구에서의 기술 및 AI 언더라이팅, 사기 탐지, 채널 경제학	PG 16
17	2032년 전망 및 출처 시나리오, 보험료 궤적, 방법론 후기	PG 17

태국 보험시장 — 인구구조에 의한 재평가

USD 310억 보험료 풀이 초고령사회로 진입하는 인구를 마주하고 있습니다. 헤드라인 성장은 완만하지만, 구성은 건강 특약·연금·노후 연계 보장 쪽으로 빠르게 이동하고 있습니다. **향후 24개월**이 어떤 사업자가 고령 고객을 선점하느냐를 결정합니다.

업계 보험료 2024

941 THB bn

전년比 +2.4% [TLAA-OIC 2024]

TLAA-OIC

건강·CI 보험료 2024

125 THB bn

+13.7%, 전체의 19.1% [TLAA 2024]

TLAA

60세 이상 인구 비율 2024

20%

1,360만 명 [GISTDA 2025]

GISTDA

개인 부담 의료비 비중

11.3%

구조적 민간 보장 격차

UHC STUDY

시장 현황

태국 보험사들은 **2024년 THB 9,410억의 보험료**를 수취하며 전년比 2.4% 성장했습니다[TLAA-OIC 2024]. 생명보험은 THB 6,540억(+3.2%)[TLAA 2024], 손해보험은 THB 2,860억(+0.5%)[TGIA 2024]입니다. 헤드라인 성장은 한 자릿수이지만 구성 변화는 빠릅니다. 건강·중대질병 보험료는 **13.7% 상승한 THB 1,250억**으로 생명보험료의 19.1%를 차지합니다[TLAA 2024].

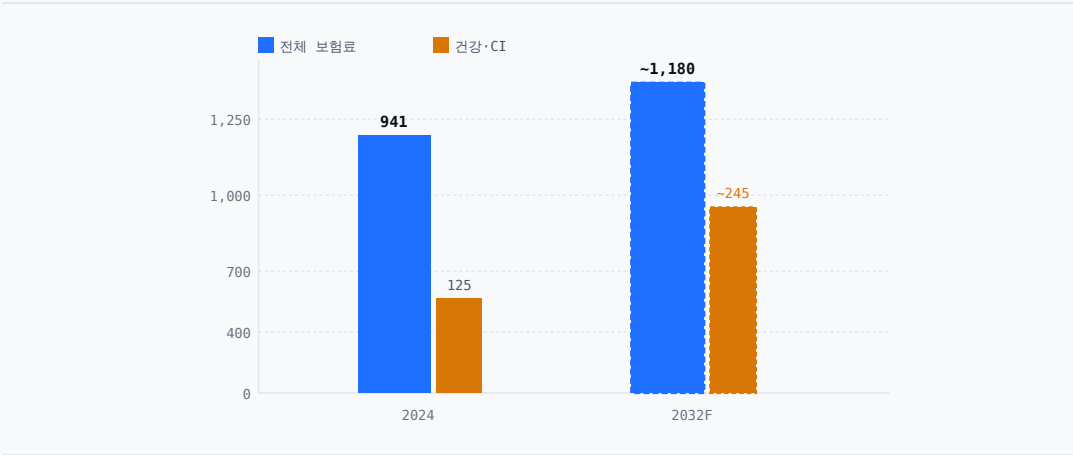
지금인 이유: 인구구조가 곧 수요 엔진

60세 이상 태국인은 **2024년 1,360만 명**, 인구의 **20%**에 달해 처음으로 아동 수를 추월했습니다[GISTDA 2025]. 2035년까지 초고령사회(60세 이상 28%)에 진입할 전망입니다[WHO 2024]. 개인 부담 지출이 의료비의 11.3%[UHC Study 2024]이고 의료 물가가 연 8~10% 상승하는[Bangkok Post 2024] 상황에서, 공적 보장이 정제되는 한 민간 보장 격차는 매년 확대됩니다.

보험료 풀과 건강 특약 비중 변화

THB BN

태국 · THB BN · 2024 실적 · 2032전망



SOURCE: TLAA, OIC, KIRA 삼각검증 · 전망 = 2024 기준 KIRA 추정 · KIRA RESEARCH 2026

출처 범위 · GISTDA 2025 = 지리정보우주기술개발원 인구 분석 2025 · TGIA 2024 = Thai General Insurance Association 직접보험료 통계 2024 · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 연간 통계 2024 · TLAA-OIC 2024 = TLAA & 보험위원회 합산 업계 총계 2024 · UHC Study 2024 = 보편적 의료보장 개인부담 연구 2024 · WHO 2024 = WHO 동남아시아 건강 고령화 특집 2024 · Bangkok Post 2024 = Bangkok Post 보험사 의료 물가 보도 2024 · Kira estimates = KIRA 자체 분석팀 삼각 검증

시장 참여자를 위한 5가지 전략적 시사점

2032년까지 경쟁 역학을 재편할 5가지 동인. 각각은 문서화된 시장 데이터와 태국의 인구구조·규제 궤적에 대한 당사 분석에 근거합니다.

01 · 수요

고령 고객의 전 생애주기를 선점

60세 이상이 **2024년 인구의 20%에서 2035년 28%로** 상승하는 가운데 [GISTDA 2025][WHO 2024], 선도 사업자는 단일 상품 판매 대신 하나의 관계 속에 건강·연금·장기요양을 묶어 제공합니다. 2027년 가치를 결정하는 것은 신규 고객 수가 아니라 교차판매 깊이입니다.

Anchor: **1,360만명**의 60세 이상 태국인 (2024)

02 · 건강 격차

보장 격차가 성장 풀

공적 보장은 인구의 74%에 도달하지 만[Frontiers 2024] 개인 부담은 지출 의 11.3%를 차지합니다[UHC Study 2024]. 건강·CI 보험료는 이미 연 **13.7% 성장**[TLAA 2024]. 중산층의 격차를 메우는 것이 단일 최대 유기적 성장 기회입니다.

Anchor: 생명보험료 중 건강 비중 **19.1%**

03 · 비용 통제

공동부담이 건강보험 경제학을 재설정

2025년 3월 19일 발효된 OIC 공동부담 조항[OIC 2025]은 연 8~10% 의료 물가에 대응해[Bangkok Post 2024] 보험계약자와 비용을 분담합니다. 공동 부담을 명확히 안내한 사업자는 손해를 지킬 수 있고, 그렇지 못한 사업자는 역선택에 직면합니다.

Anchor: 연간 의료 물가 **8~10%**

04 · 자본

IFRS 17·RBC는 대형 사업자 유리

위험기준자본과 IFRS 17은 장기 보증 비용을 높입니다[OIC 2025]. 연금 중심 포트폴리오는 엄격한 자산부채관리 가 필요합니다. **소규모 보험사**는 상위 3사 대비 구조적 자본 열위에 처하며 선별적 통합이 예상됩니다.

Anchor: 상위 3사 합산 **~53%** 점유

05 · 디지털

AI가 파일럿에서 언더라이팅 핵심으로

선도적 도입 사례에서 사기 보험금을 **~30% 감소**시킨 AI 언더라이팅·청구 자동화·사기 모델[InsurTech 2025]은 2027년에는 기본 역량입니다. 방카슈랑스와 에이전트는 고령 계약자에게 여전히 신뢰 채널이며, 디지털은 대체가 아닌 보완입니다.

Anchor: 사기 청구 감소 **~30%**

출처 범례 · Frontiers 2024 = Frontiers in Public Health, 태국 보편적 의료보장 저비용 2024 · GISTDA 2025 = GISTDA 인구 분석 2025 · InsurTech 2025 = InsurTech Digital AI 청구·언더라이팅 검토 2025 · OIC 2025 = 보험위원회 2025 지침(공동부담, RBC, IFRS 17) · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 통계 2024 · UHC Study 2024 = 보편적 의료보장 개인부담 연구 2024 · WHO 2024 = WHO 동남아시아 건강 고령화 특집 2024 · Bangkok Post 2024 = Bangkok Post 의료 물가 보도 2024

SECTION 06

인구구조 전환

태국은 동일 소득 수준의 어떤 경제보다 빠르게 고령화되고 있습니다. 60세 이상 코호트는 **2024년 인구의 20%를 돌파**하여 2035년 28%를 향해 나아갑니다 — 초고령사회입니다. 이것은 보험 이야기의 배경이 아닙니다. 이것이 **곧** 그 이야기입니다.

[6.1 연령 구조](#)[6.2 초고령사회 경로](#)[6.3 지역별 격차](#)[6.4 수요에의 영향](#)

고령사회에서 초고령사회로: 보장 수요 엔진

60세 이상 태국인 비율은 2000년 10%에서 **2020~2024년 20%**로 두 배가 됐으며[World Bank 2023][GISTDA 2025], 2050년 36%에 달할 전망입니다. 비율 1%p 상승마다 수요는 적립형 상품에서 건강·연금·장기요양 쪽으로 이동합니다.

역전된 인구 피라미드

2024년 60세 이상 인구는 **1,360만 명으로 15세 미만 아동 950만 명을 처음으로 추월**했습니다[GISTDA 2025]. 줄어드는 생산가능인구가 늘어나는 고령 피부양 인구를 부양해야 하는 고령화 사회의 전형적 구조가, 동남아 역내 국가보다 일찍 태국에서 도래했습니다.

초고령사회 진입 시점

WHO는 태국이 60세 이상 28%의 초고령사회에 **2035년**에 진입한다고 전망합니다[WHO 2024]. 2050년에는 인구의 약 36%가 60세 이상이 됩니다[World Bank 2023]. 장수화는 보험사가 언더라이팅해야 하는 건강·요양 부채의 존속 기간을 연장합니다.

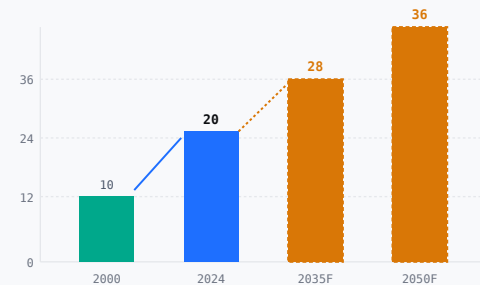
지역별 격차

북부·중부·북동부는 저출산과 생산가능인구 이출로 인해 이미 가장 높은 고령화 지수를 기록하고 있습니다[GISTDA 2025]. 지방 미시시장은 상이한 속도로 성숙하며, 농촌 유통 투자의 회수 가능성을 지역별로 달리 합니다.

60세 이상 인구 비율

% 60+

태국 · 인구 대비 % · 2000-2050F



SOURCE: WORLD BANK, GISTDA, WHO · KIRA ANALYSIS · KIRA RESEARCH 2026

15세 미만 아동, 2024

9.5m

60세 이상 코호트에 미달

GISTDA

초고령사회 진입 시점

2035

60세 이상 28% [WHO 2024]

WHO

60세 이상 비율 2050

36%

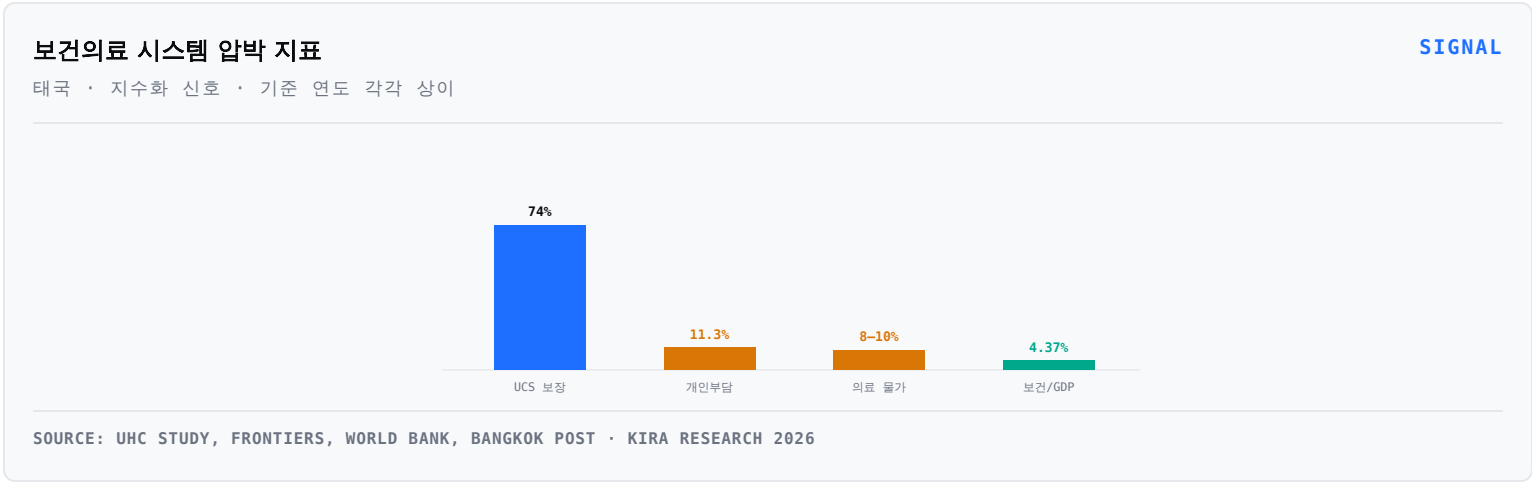
2000년 10%에서 상승

WORLD BANK

출처 범례 · GISTDA 2025 = GISTDA 인구 분석 2025 · WHO 2024 = WHO 동남아시아 건강 고령화 특집 2024 · World Bank 2023 = World Bank, 태국 고령 인구 돌봄 2023

공적 보장이 끝나는 곳에서 민간 보장이 시작된다

태국의 조세 재원 보편적 의료보장(UCS)은 명실상부한 성과입니다 — 그러나 폭넓음이 곧 깊이를 의미하지는 않습니다. 인구가 고령화되고 의료비가 일반 물가를 앞서가면서 **민간 건강보장 격차**는 가장 중요한 상업적 기회가 됩니다.



왜 격차는 더 벌어지는가

보건 지출은 **2023년 GDP의 4.37%**로, 2028년까지 ~4.49%로 소폭 상승하는 수준에 그칩니다[World Bank 2023]. 보건부는 총 보건 지출을 GDP의 5%로 제한하고 있습니다. 그러나 피부양 노인 장기요양 비용은 **2040년 THB 5,000억**에 달할 전망이며, 노인 의료비는 2032년까지 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다[NER 2024]. 재정 여력만으로는 고령화 곡선을 감당할 수 없습니다.

상업적 시사점

중산층은 기본 공적 의료와 자신이 기대하는 수준(개인 병실, 빠른 접근, 만성질환 관리) 사이의 차이를 점점 더 자비로 충당하고 있습니다. 이것이 건강 특약과 단독 건강보험이 포착하는 수요이며, 해당 세그먼트에서 **13.7% 보험료 성장**을 설명합니다[TLAA 2024]. 보장 격차는 비판받을 시장 실패가 아니라 책임감 있게 언더 라이팅해야 할 어드레서블 풀입니다.

폭은 넓지만 깊이는 얕다

UCS는 인구의 약 **74%**를 포괄하지만[Frontiers 2024], 예산이 의료비를 따라가지 못하고 민간 의료기관 이용 시 개인 부담이 **의료 지출의 11.3%**에 달합니다[UHC Study 2024].

UCS 적용 인구	~74%
개인 부담 비중	11.3%
보건 지출/GDP 2023	4.37%
의료 물가 상승률	8~10%

출처 범례 · Frontiers 2024 = Frontiers in Public Health, UCS 저이용 2024 · NER 2024 = Development Economic Review, 미래 보건 지출·장기요양 2024 · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 통계 2024 · UHC Study 2024 = 보편적 의료보장 개인부담 연구 2024 · World Bank 2023 = World Bank 태국 고령화·지출 2023

종목별 보험료: 건강 특약과 연금이 성장을 주도

생명보험이 보험료 풀을 지배하지만, 성장은 보장형·노후 상품에 집중됩니다. **종신 적립형은 성숙기에 접어들었고**, 건강 특약·중대질병·연금이 인구구조 순풍을 타고 2027년을 이끕니다.

생명 주도, 손해 안정

생명보험료 **THB 6,540억(+3.2%)**은 손해보험 THB 2,860억(+0.5%)을 크게 앞섭니다[TLAA 2024][TGIA 2024]. 손해보험 내에서 건강보험은 2025년 상반기 24% 급등한 반면 자동차보험은 2% 소폭 상승에 그쳤습니다[TGIA 2025] — 고령화 신호가 양쪽 포트폴리오에 가시적입니다.

특약과 연금이 성장 엔진

종신보험이 생명 원수보험료의 ~60%를 차지하지만, 부가특약은 **22.3%를 점유하며 더 빠르게 성장**합니다 [GlobalData 2025]. 건강·CI 특약의 CAGR은 2028년까지 5.4%로 전망됩니다[GlobalData 2025]. 90~99 세까지 지급하는 연금은 초고령사회의 자연스러운 노후 소득 수단입니다[Muang Thai 2025].

USD 기준

전체 시장은 **2024년 약 USD 310억**으로, 4.1% CAGR로 2029년 USD 380억에 달할 전망입니다[Statista 2025]. 생명보험만 2028년 USD 230억에 이를 것으로 예측됩니다[GlobalData 2025].

2024년 종목별 보험료

THB BN

태국 · THB BN · 생명 VS 손해 VS 건강·CI



SOURCE: TLAA, TGIA, GLOBALDATA, STATISTA · KIRA ANALYSIS · KIRA RESEARCH 2026

생명보험료 2024

654 THB bn

전년比 +3.2% [TLAA 2024]

TLAA

손해 건강보험, 2025 상반기

+24%

손해 최고 성장 종목 [TGIA 2025]

TGIA

2029년 시장 규모

38 USD bn

4.1% CAGR [Statista 2025]

STATISTA

출처 범례 · GlobalData 2025 = GlobalData 태국 생명보험 시장 분석 2025 · Muang Thai 2025 = Muang Thai Life 연금 상품 공시 2025 · Statista 2025 = Statista 태국 보험 시장 전망 2025 · TGIA 2024 = Thai General Insurance Association 통계 2024 · TGIA 2025 = Thai General Insurance Association 2025 상반기 업데이트 · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 통계 2024

SECTION 10

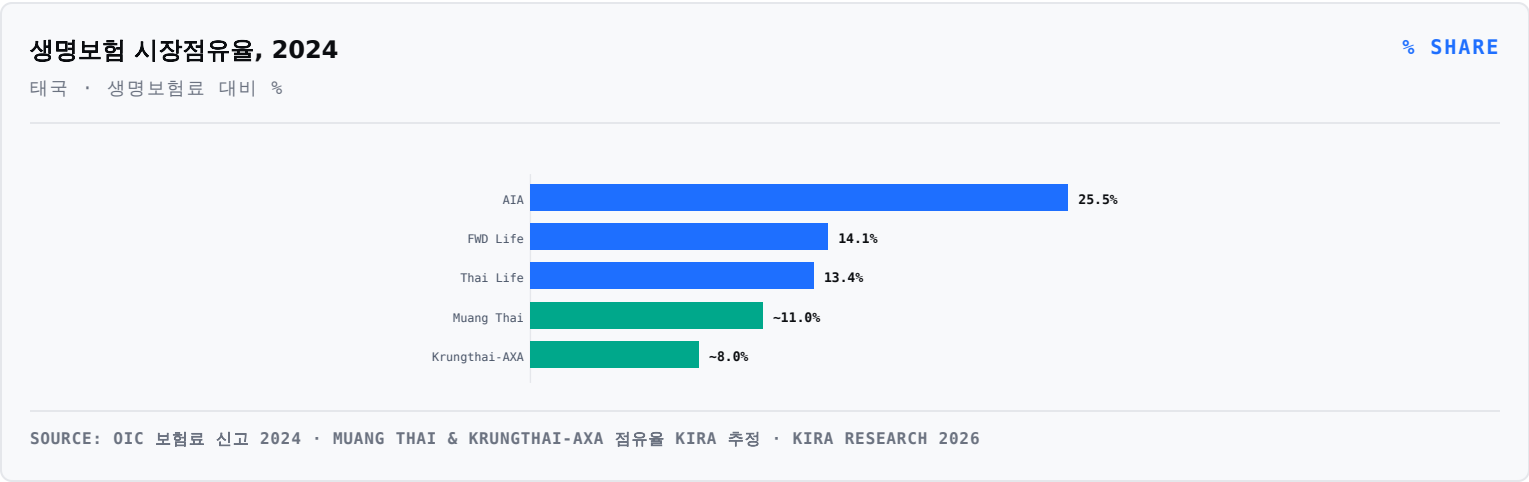
경쟁 구조

태국 생명보험은 규모의 게임입니다. 상위 3사 — **AIA, FWD, Thai Life** — 가 전체 보험료의 절반 이상을 점유하며, 인구구조 전환은 고령화 생애주기에 걸쳐 재무 안정성·유통 신뢰·상품 다양성을 갖춘 사업자를 보상합니다.

[10.1 시장 점유율](#)[10.2 상위 5사](#)[10.3 선도 사업자 프로필](#)[10.4 유통](#)

시장 구조: 집중화·외국 자본 주도·규모 확대

상위 3개 생명보험사가 보험료의 약 **53%**를 점유하는[OIC 2024] 중고도 집중 구조입니다. 외국계 모회사는 자본력과 계리 역량을 제공하며, 인구구조 전환은 대형 사업자와 후발 군소사 간의 격차를 더욱 벌립니다.



규모와 모회사	
AIA는 25.5%(THB 1,670억) 로 선두이며, FWD 14.1%(THB 920억), Thai Life 13.4%(THB 880억)[OIC 2024]. 외국계 및 은행 연계 모회사가 선두 사업자의 자본 건전성을 뒷받침합니다.	
상위 3사 합산 점유율	~53%
AIA 보험료	THB 167 bn
FWD 보험료	THB 92 bn
Muang Thai 보험료	THB 72 bn

MARKET LEADER RANK 01 AIA Thailand AIA Group (홍콩) 점유율 25.5% 보험료 THB 167 bn 채널 에이전시 중심 강점: 최대 규모 전속 에이전트, 건강·보장 집중, 광역 재무 기반.	RANK 02 FWD Life Insurance FWD Group (범아시아) 점유율 14.1% 보험료 THB 92 bn 채널 방카 + 디지털 강점: 디지털 퍼스트 브랜드, 강력한 방카슈랑스, 보장형 포트폴리오 고성장.	RANK 03 Thai Life Insurance 국내 상장사 (SET: TLI) 점유율 13.4% 보험료 THB 88 bn 채널 에이전시 중심 강점: 깊은 국내 브랜드 신뢰, 고령자 특화 상품, 상장사 투명성.	RANK 04 Muang Thai Life Muang Thai Group / Ageas 제휴 보험료 THB 72 bn 집중 영역 연금·노후 채널 방카 (Kasikorn) 강점: 노후 상품 깊이(99세까지 연금), 강력한 은행 유통망.
--	---	---	---

AIA Thailand AIA Group 자회사 · 홍콩 상장 범아시아 보험사 시장 선도 건강·보장 KIRA TIER 1	생명 점유율 25.5 %	보험료 167 THB bn	주요 채널 에이전시	모회사 AIA Grp
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

시장 포지션

AIA는 태국 생명보험의 명확한 선두 사업자로, **2024년 THB 1,670억·점유율 25.5%**를 기록했습니다[OIC 2024] — 2위 사업자의 거의 두 배입니다. 이 규모는 국내 최대 전속 에이전트 조직과 순수 저축 상품이 아닌 건강·보장 상품 집중 전략에 기반합니다.

고령 고객을 선점하는 이유

건강 특약·중대질병·시니어 생명보험에 걸친 상품 깊이는 인구구조 전환과 정확히 맞닿습니다. 건강·CI 보험료가 업계 전반에서 **연 13.7% 성장**하는 가운데[TLAA 2024], AIA의 보장 중심 포지셔닝은 해당 풀의 불균형적 점유를 가능케 합니다.

전략 방향

그룹 자본 건전성은 RBC·IFRS 17 강화 체제 하에서 장기 건강·연금 보증을 지원합니다[OIC 2025]. AIA는 고령 계약자가 선호하는 대면 에이전트 신뢰와 디지털 언더라이팅·청구에 대한 지속 투자를 병행하여, 시장이 재편되는 가운데 점유율을 지킵니다.

강점 및 주시 사항

- **에이전트 규모:** 최대 대면 조직, 고령 계약자에게 결정적
- **보장 집중:** 건강·CI 집중이 인구구조 순풍을 탐
- **자본 깊이:** 광역 모회사가 RBC·IFRS 17 부담 경감
- **주시:** FWD의 디지털 방카 모멘텀; 공동부담 안내 리스크

출처 범례 · OIC 2024 = 보험위원회 생명보험료 신고 2024 · OIC 2025 = 보험위원회 2025 지침 (RBC, IFRS 17) · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 통계 2024

SECTION 11

규제와 비용 통제 기초

보험위원회는 지속가능성을 향해 방향을 전환했습니다. **2025년 3월 공동부담 조항**과 위험기
준자본, IFRS 17은 의료비 상승 속에서 손해율 규율과 재무 건전성을 중시하는 감독 체계를
신호합니다.

11.1 공동부담

11.2 RBC & IFRS 17

11.3 신건강표준

11.4 승자와 피압박자

성장이 아닌 지속가능성을 위해 설계된 감독 체계

인구구조·의료비 곡선이 가파라지는 상황에서, OIC의 2025년 의제 — 공동부담, 위험기준자본, IFRS 17, ESG — 는 명시적으로 **장기 지급여력**을 겨냥합니다. 가격·자본·공시를 조기에 정렬한 사업자가 저항하는 사업자를 앞서 나갑니다.

공동부담: 수요 측 브레이크

2025년 3월 19일 이후 신규 개인보험에 적용된 공동부담 조항[OIC 2025]은 과잉 이용을 억제하고 보험료를 안정화하기 위해 청구 비용을 계약자와 분담합니다. 신건강표준(OIC 지시 14~15/2564) 하에 도입된 이 조항은 연 **8~10% 의료 물가**에 대한 의도적 대응책입니다[Bangkok Post 2024].

RBC와 IFRS 17

위험기준자본과 IFRS 17은 장기 보증의 자본 비용을 높입니다[OIC 2025]. 연금·종신보험 포트폴리오는 투명한 자본 요건을 부담하므로, 자산부채관리가 엄격하고 모회사 자본이 충분한 사업자가 유리합니다.

시장 참여자에의 시사점

비용 통제 기조는 **규모·계리 전문성·명확한 고객 소통**을 갖춘 사업자에게 유리합니다. 공동부담을 잘 설명한 사업자는 신뢰를 유지하고 손해율을 보호하며, 계약자를 놀라게 한 사업자는 실효·역선택 위험에 처합니다.

- **승자:** 자본 충실, 건강 집중, 계리 기능 강화된 선도 사업자
- **피압박자:** RBC·IFRS 17 하에서 자본이 부족한 소규모 보험사
- **핵심 변수:** 신뢰를 훼손하지 않고 공동부담을 설명할 수 있는 유통망
- **부상 중:** 비교·가격 경쟁을 용이하게 하는 표준화 상품

OIC의 2025년 광범위한 프레임워크는 새로운 글로벌 리스크에 대응해 금융 시스템을 강화하는 13가지 메커니즘을 나열하고 있습니다[OIC 2025] — 다음 사이클이 헤드라인 성장이 아닌 회복력으로 정의된다는 명확한 신호입니다.

기술이 파일럿에서 언더라이팅 핵심으로 이동

언더라이팅·청구·사기 탐지에서 AI는 글로벌 업계 전반에서 차별화 요소에서 **기본 역량**으로 이행했습니다[InsurTech 2025]. 고령화된 계약자를 서비스하는 태국 보험사에게 목표는 신속한 온보딩, 손해율 통제, 신뢰할 수 있는 인적 조연자를 존속시키는 채널 경제학입니다.

실험에서 인프라로

선도 보험사와 인슈어텍 기업들은 고객 서비스·언더라이팅·청구·사기 예측 전반에 머신러닝 모델을 운용하고 있습니다[InsurTech 2025]. 2026년에는 이것이 경쟁 우위가 아니라 기본 역량이며, 태국 사업자들도 핵심 업무 흐름에 통합하고 있습니다.

사기 탐지와 손해율 통제

AI 사기 탐지는 선도적 도입 사례에서 **사기 보험금을 최대 ~30% 감소**시켰습니다[InsurTech 2025]. 공동부담 체계와 결합하면, 태국 건강보험사는 의료비 상승에 대응하는 두 번째 레버를 확보합니다.

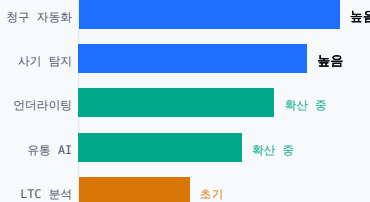
채널: 대체가 아닌 보완

고령 계약자는 여전히 대면 상담과 방카슈랑스를 신뢰합니다. 현실적인 태국 패턴은 **AI 보강 에이전트 및 방카** — 디지털 도구가 견적·언더라이팅·청구를 가속하는 동시에 인적 관계가 판매를 고정하는 방식입니다.

태국 보험에서 AI 선착 영역

MATURITY

도입 성숙도 · 방향성 전망



SOURCE: INSURTECH DIGITAL, NORTON ROSE FULBRIGHT · KIRA ANALYSIS · KIRA RESEARCH 2026

사기 보험금 감소

~30%

선도적 AI 도입 사례 [InsurTech 2025]

INSURTECH

2026년 기준

기본 역량

AI 청구·언더라이팅 [InsurTech 2025]

INSURTECH

태국 채널 우선순위

방카 + 에이전트

고령 계약자의 신뢰 채널

KIRA EST.

출처 범례 · InsurTech 2025 = InsurTech Digital, AI 청구·언더라이팅 검토 2025 · Kira estimates = KIRA 자체 분석팀 삼각 검증

태국 보험사를 재편하는 6가지 기술 활용 사례

실제 운영에의 전환이 2027년 승자와 후발자를 가릅니다. 이 활용 사례들은 **고객 유치부터 청구 통제**까지 걸쳐 있으며, 현재 태국 또는 가장 근접한 역내 벤치마크에서 관찰 가능합니다.

01 · 언더라이팅

알고리즘 건강 언더라이팅

ML 모델이 고령 신청자의 건강·CI 리스크를 더 빠르고 세밀하게 산정하여, 과거에는 일괄 거절되던 피보험 연령을 확대합니다. 60세 이상 계층을 수익성 있게 포착하는 데 결정적입니다.

벤치마크: 범아시아 보험사

02 · 청구

직선처리 청구 자동화

AI가 일상적 건강보험 청구를 수동 처리 없이 심사·지급하여 처리 시간과 비용을 단축합니다. 공동부담 규정과 결합하면 규모에 맞게 일관성 있고 감사 가능한 심사를 시행합니다.

현황: 글로벌 고성속도

03 · 사기

청구 사기 탐지

패턴 모델이 이상 건강보험 청구를 표지하여 선도적 도입 사례에서 사기 지급액을 최대 **~30%** 감소시킵니다[InsurTech 2025]. 의료비 상승 속에서 직접적인 손해를 레버입니다.

ANCHOR: ~30% 사기 감소

04 · 유통

에이전트·방카 역량 강화

추천 엔진이 상담 시점에 각 고객에게 적합한 연금·건강 특약을 제시하여, 신뢰할 수 있는 인적 채널을 유지하면서 고령화 생애주기 전반의 교차판매를 제고합니다.

관찰: 방카슈랑스 선도 사업자

05 · 유지율

실효·유지율 모델링

예측 모델이 실효 위험 보험계약을 조기에 식별합니다 — 공동부담 변경으로 기대가 달라진 계약자에서 특히 두드러집니다. 장기 건강·연금 포트폴리오를 지키는 선제적 아웃리치를 가능케 합니다.

연계: 공동부담 안내

06 · 요양 분석

장기요양 리스크 분석

신흥 모델들이 노인의 의존도와 요양비 궤적을 전망합니다 — **THB 5,000억**에 달할 2040년 요양비 파고[NER 2024]에 대비한 LTC 상품 가격 산정의 기반입니다.

단계: 초기, 전략적 가치 높음

출처 범례 · InsurTech 2025 = InsurTech Digital, AI 청구·언더라이팅 검토 2025 · NER 2024 = Development Economic Review, 장기요양 비용 전망 2024

2032년 전망: 완만한 헤드라인, 결정적인 구성 변화

당사는 태국 보험료 성장이 저~중 한 자릿수에 머물 것으로 예상하며, 인구구조 전환이 건강 특약·연금·장기요양에서 추세 이상의 성장을 이끌 것으로 봅니다. 승자는 지금 고령 고객 쪽으로 포지셔닝을 재편하는 사업자입니다.

기본 시나리오

업계 보험료는 **2029년까지 ~4% 복합 성장**[Statista 2025]하며, 생명보험은 2028년까지 ~USD 230억에 달합니다[GlobalData 2025]. 건강·CI는 보장 격차와 의료 물가가 지속되며 시장을 상회하는 고 한 자릿수~저 두 자릿수 성장을 기록합니다[TLAA 2024][GlobalData 2025].

상승 및 하강 리스크

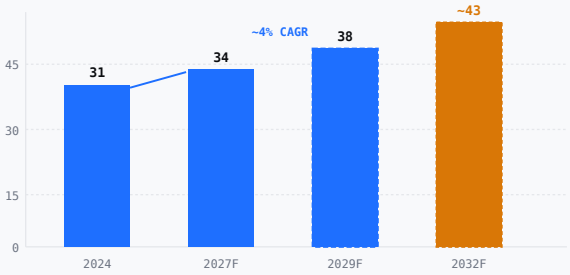
상승: 중산층의 민간 건강 가입 가속, 세금 혜택 연금, LTC 상품 혁신. 하강: 경기 침체로 인한 임의적 보장 지출 위축, 또는 공동부담 마찰로 인한 건강 특약 단기 판매 둔화.

전략적 과제

인구구조 곡선이 이 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 변수입니다. **60세 이상 생애주기 — 건강·연금·LTC — 로 포트폴리오를 재편**하고, 자본 건전성과 AI 보장 유통에 투자하십시오. 소규모·저축 중심 보험사가 가장 큰 조정을 마주합니다.

전체 보험료 궤적

태국 · USD BN · 2024–2032F



SOURCE: STATISTA, GLOBALDATA · 2032 수치 ~4% CAGR 기준 KIRA 추정 · KIRA RESEARCH 2026

2027 시장 (기본)

~34 USD bn
~4% CAGR 기준 [Kira estimates]

KIRA EST.

생명보험 2028

23 USD bn
[GlobalData 2025]

GLOBALDATA

LTC 비용 파고 2040

500 THB bn
피부양 노인 요양 [NER 2024]

NER

출처 범례 · GlobalData 2025 = GlobalData 태국 생명보험 시장 분석 2025 · NER 2024 = Development Economic Review 장기요양 비용 전망 2024 · Statista 2025 = Statista 태국 보험 전망 2025 · TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association 통계 2024 · Kira estimates = KIRA 자체 분석팀 삼각 검증

방법론 및 출처 색인

본 분석은 규제·협회 통계, 인구·보건 시스템 연구, 사업자 공시를 KIRA 분석팀의 삼각 검증과 결합합니다. 전망 수치는 문서화된 기준 연도에 고정된 방향성 시나리오이며 점 예측이 아닙니다. 정량적 주장의 약 5분의 1이 KIRA 추정치이며, 나머지는 명명된 외부 출처를 인용합니다.

출처 색인

[1] Thai Life Assurance Association — life premium statistics and annual report 2024.

[2] Thai General Insurance Association — non-life direct-premium statistics 2024 and H1 2025.

[3] Office of Insurance Commission — 2024 premium filings; 2025 industry directives, copayment clause, RBC and IFRS 17.

[4] GISTDA — 2025 population analysis on elderly versus child cohorts.

[5] World Health Organization — South-East Asia healthy-ageing feature, super-aged projection to 2035.

[6] World Bank — Caring for Thailand's Aging Population; health expenditure series 2023.

[7] Universal Coverage Scheme utilisation and out-of-pocket study, 2024.

[8] Frontiers in Public Health — determinants of low UCS use, 2024.

[9] Development Economic Review — future health expenditure and long-term care costs, 2024.

[10] Statista — Thailand insurance market forecast, 2025.

[11] GlobalData — Thailand life insurance market analysis and 2028 forecast, 2025.

[12] Bangkok Post — insurer growth and medical-inflation reporting, 2024.

[13] Muang Thai Life — annuity and retirement product disclosures, 2025.

[14] InsurTech Digital — generative AI in claims and underwriting, 2025.

[15] KIRA Research — in-house analyst triangulation across the above.